



Nombre: ALMA VICTORIA REYES SEGUNDO

Afiliación: 1609890818

Fecha Ingreso: 10/06/2024

Agregado: 1F1989OR

Fecha Ingreso a Cama: 10/06/2024 20:03

Cama:

Fecha Egreso: 10/06/2024 20:25

Diagnóstico de Ingreso:

Z352-SUPERVISION DE EMBARAZO CON OTRO RIESGO EN LA HISTORIA OBSTETRICA O REPRODUCTIVA

Diagnóstico de Egreso:

O233 - INFECCION DE OTRAS PARTES DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO

Z352 - SUPERVISION DE EMBARAZO CON OTRO RIESGO EN LA HISTORIA OBSTETRICA O REPRODUCTIVA

Tipo de Egreso:

DOMICILIO

Observación: NO

Fecha y Hora 10/06/2024 20:25 TA 120/080 FC 67 FR 21 TEMP 36.7 °C SAT. 02 96 %

Nota Alta y Tratamiento:

P. Alma 34 años G3 C2, FUM 20/03/2024 con los diagnósticos: Embarazo de 11.5 SDGxFUM + Sin Amenaza de aborto + Multigesta + Infección de vía urinarias (IVU)

S. Refiere que acude a valoración por referir salida de sangre posterior al ir al baño, niega alguna otra sintomatología de trascendencia. Actualmente niega algias-acufenos-fosfenos, afebril, tolera vía oral y deambulación al momento de la valoración, niega pérdidas transvaginales, refiere sintomatología urinaria (tenesmo vesical, poliaquiuria, disuria, urgencia miccional), niega sintomatología asociada a COVID19, resto preguntado y negado.

Ef. Alerta, consiente, orientada, adecuada coloración de piel y tegumentos, regular estado de hidratación, facies no característica, Glasgow no traumático 15 puntos, cuello sin megalias ni masas, cardiopulmonar sin compromiso, mamas íntegras, simétricas, no congestivas o lactopoyéticas, abdomen plano, blando, sin datos de irritación peritoneal, FCF no valorable, Giordanos y puntos ureterales negativos, tacto vaginal cervix acortado 30%, en bisel, no permeable, posterior, sin pérdidas transvaginales evidenciado en toalla testigo, sin fetidez, extremidades íntegras, buen llenado capilar, reflejos de estiramiento muscular +/++.

Rastreo por USG Pélvico: LCR de 12.3SDG, ovario izquierdo 32.6x40.5x29.9mm volumen de 20.67mL.

A. Paciente de la cuarta década de la vida con los diagnósticos ya comentados, manteniéndose sin déficit o deterioro neurológico, hemodinámico estable, sin falla respiratoria, sin datos de abdomen agudo, eutermica sin datos de SIRS, sin urgencia obstétrica o quirúrgica en este momento que amerite hospitalización, con clínica de IVU que indicamos manejo.

P. Plan: Envío a UMF para seguimiento. Nitrofurantoína tabletas 100mg una VO cada 6 horas por 10días, Indometacina supositorios 100mg VR uno cada 12 horas por 6 dosis.

Cita abierta a urgencias en caso de Datos de alarma Obstétricos (Náuseas y vómitos frecuentes, pérdida de líquido o sangre por la vagina o genitales, dolor abdominal persistente en vientre bajo de cualquier intensidad, contracciones uterinas cada 3 a 5 minutos antes de las 37 semanas, fiebre, fuerte dolor de cabeza, disminución o ausencia de movimientos del feto por más de 2 horas después de las 28 semanas, hinchazón de pies-manos o cara, zumbido de oídos, visión borrosa con puntos de lucecitas, palidez marcada, aumento de peso mayor a 2 kilos por semana, dificultad para respirar, aumento en el número de micciones y molestias al orinar, convulsiones) o datos sugestivos de COVID-19.

DIETA: ingesta de abundantes líquidos (sobre todo cítricos como piña, naranja, limón, Jamaica entre otros), sin grasas ni irritantes, evitar tomar Tes oscuros (café, chocolate, etc) y/o refrescos oscuros, evitar lácteos.

Pronóstico bueno para la vida, no exenta de complicaciones. Manejo apoyado en las guías de la práctica clínica: GPC-IMSS-028-08 actualización 2017 (Control Prenatal con atención centrada en la paciente), GPC-SS-026-20 actualización 2020 (Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Referencia de la paciente con Amenaza de Aborto en el primer y segundo nivel de atención), GPC-IMSS-088-08 actualización 2010 (Diagnóstico y Tratamiento del Aborto Espontáneo y manejo inicial del Aborto Recurrente), GPC-SS-831-21 actualización 2021 (Prevención, Abordaje y Manejo de Bacteriuria Asintomática e Infección de Vías Urinarias durante el embarazo) y GPC-IMSS-078-08 actualización 2016 (Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la infección del tracto urinario bajo durante el embarazo, en el Primer Nivel de Atención).

JORGE TONATIUH PEREZ CRUZ
MA GYO MATRICULA 97161996



Nombre: ALMA VICTORIA REYES SEGUNDO

Fecha Ingreso:

10/06/2024

Fecha Ingreso a Cama:

10/06/2024 20:03

Fecha Egreso:

10/06/2024 20:25

Diagnóstico de Ingreso:

Z352-SUPERVISION DE EMBARAZO CON OTRO RIESGO EN LA HISTORIA OBSTETRICA O REPRODUCTIVA

Diagnóstico de Egreso:

O233 - INFECCION DE OTRAS PARTES DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO

Z352 - SUPERVISION DE EMBARAZO CON OTRO RIESGO EN LA HISTORIA OBSTETRICA O REPRODUCTIVA

Tipo de Egreso:

DOMICILIO

Observación: NO

Fecha y Hora

10/06/2024 20:25

TA

120/080

FC

67

FR

21

TEMP

36.7 °C

SAT. 02

96 %

Nota Alta y Tratamiento:

P. Alma 34 años G3 C2, FUM 20/03/2024 con los diagnósticos: Embarazo de 11.5 SDGxFUM + Sin Amenaza de aborto + Multigesta + Infección de vía urinarias (IVU)

S. Refiere que acude a valoración por referir salida de sangre posterior al ir al baño, niega alguna otra sintomatología de trascendencia. Actualmente niega algias-acufenos-fosfenos, afebril, tolera vía oral y deambulación al momento de la valoración, niega pérdidas transvaginales, refiere sintomatología urinaria (tenesmo vesical, poliaquiuria, disuria, urgencia miccional), niega sintomatología asociada a COVID19, resto preguntado y negado.

Ef. Alerta, consiente, orientada, adecuada coloración de piel y tegumentos, regular estado de hidratación, facies no característica, Glasgow no traumático 15 puntos, cuello sin megalias ni masas, cardiopulmonar sin compromiso, mamas íntegras, simétricas, no congestivas o lactopoyéticas, abdomen plano, blando, sin datos de irritación peritoneal, FCF no valorable, Giordanos y puntos uretrales negativos, tacto vaginal cervix acortado 30%, en bisel, no permeable, posterior, sin pérdidas transvaginales evidenciado en toalla testigo, sin fetidez, extremidades íntegras, buen llenado capilar, reflejos de estiramiento muscular +/++.

Rastreo por USG Pélvico: LCR de 12.3SDG, ovario izquierdo 32.6x40.5x29.9mm volumen de 20.67mL.

A. Paciente de la cuarta década de la vida con los diagnósticos ya comentados, manteniéndose sin déficit o deterioro neurológico, hemodinámico estable, sin falla respiratoria, sin datos de abdomen agudo, eutermica sin datos de SIRS, sin urgencia obstétrica o quirúrgica en este momento que amerite hospitalización, con clínica de IVU que indicamos manejo.

P. Plan: Envío a UMF para seguimiento. Nitrofurantoína tabletas 100mg una VO cada 6 horas por 10días, Indometacina supositorios 100mg VR uno cada 12 horas por 6 dosis.

Cita abierta a urgencias en caso de Datos de alarma Obstétricos (Náuseas y vómitos frecuentes, pérdida de líquido o sangre por la vagina o genitales, dolor abdominal persistente en vientre bajo de cualquier intensidad, contracciones uterinas cada 3 a 5 minutos antes de las 37 semanas, fiebre, fuerte dolor de cabeza, disminución o ausencia de movimientos del feto por más de 2 horas después de las 28 semanas, hinchazón de pies-manos o cara, zumbido de oídos, visión borrosa con puntos de lucecitas, palidez marcada, aumento de peso mayor a 2 kilos por semana, dificultad para respirar, aumento en el número de micciones y molestias al orinar, convulsiones) o datos sugestivos de COVID-19.

DIETA: ingesta de abundantes líquidos (sobre todo cítricos como piña, naranja, limón, Jamaica entre otros), sin grasas ni irritantes, evitar tomar Tes oscuros (café, chocolate, etc) y/o refrescos oscuros, evitar lácteos.

Pronóstico bueno para la vida, no exenta de complicaciones. Manejo apoyado en las guías de la práctica clínica: GPC-IMSS-028-08 actualización 2017 (Control Prenatal con atención centrada en la paciente), GPC-SS-026-20 actualización 2020 (Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Referencia de la paciente con Amenaza de Aborto en el primer y segundo nivel de atención), GPC-IMSS-088-08 actualización 2010 (Diagnóstico y Tratamiento del Aborto Espontáneo y manejo inicial del Aborto Recurrente), GPC-SS-831-21 actualización 2021 (Prevención, Abordaje y Manejo de Bacteriuria Asintomática e Infección de Vías Urinarias durante el embarazo) y GPC-IMSS-078-08 actualización 2016 (Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la infección del tracto urinario bajo durante el embarazo, en el Primer Nivel de Atención).

JORGE TONATIUH PEREZ CRUZ
MA GYO MATRICULA 97161996